

Qualità di Vita e Progettualità

Percorsi nella Disabilità · Sessione 10 · 28 aprile 2026

Questa lezione è il grande mosaico che mette insieme tutto quello che hai studiato finora: l'ICF, la Convenzione ONU, l'inclusione. Il filo che li unisce è il paradigma della **Qualità di Vita** — un concetto che sembra intuitivo, ma che per diventare utile nella pratica va "spacchettato" con metodo. E lo strumento principale per farlo? Il **progetto di vita**.

Il Cambio di Sguardo: da Medico a Bio-Psico-Sociale

Prima di entrare nella qualità di vita, la professoressa ripassa il cambio epocale che hai già incontrato nelle lezioni precedenti. È importante tenerlo a mente perché tutto il resto si regge qui.

Sguardo medico-individualista: - La persona è la sua diagnosi e il suo deficit - Gli specialisti hanno il sapere, l'operatore "prescrive" ("devi fare così!") - Il futuro è standardizzato e statico - La priorità è la protezione dai rischi, postura paternalistica

Sguardo bio-psico-sociale (ICF + Convenzione ONU): - La diversità è un modo originale di relazionarsi al mondo - Tutti hanno potenziali di sviluppo - Il focus si sposta dal deficit alla persona nel suo contesto - L'operatore accompagna ("cosa vorresti fare?"), lavora sui contesti, costruisce reti di sostegno - Si accetta il rischio dell'indipendenza

In pratica, si passa da:

Vecchio paradigma	Nuovo paradigma
Eterno bambino	Adulthood
Dipendenza	Autonomia

Vecchio paradigma	Nuovo paradigma
Malattia / diagnosi	Funzionamento / sostegni
Emarginazione	Inclusione
Bisogni	Diritti e desideri
Deficit individuali	Contesti e barriere
Esclusione	Partecipazione

La prof sottolinea che questo cambiamento non è solo teoria: lo verificherete concretamente in stage. Molti servizi sono ancora ancorati al vecchio paradigma, e la responsabilità di chi entra nel campo adesso è proprio quella di rendere concreti i nuovi approcci.

Il Paradigma della Qualità di Vita (QdV)

Cos'è e perché ci serve

Nel 1990, Edgerton osservava che sappiamo "troppo poco della qualità della vita delle persone con disabilità intellettiva e quasi nulla in merito alla loro soddisfazione". Da lì è partito un lavoro scientifico durato decenni.

Definizione OMS (1995):

"La percezione dell'individuo della propria posizione nella vita nel contesto dei sistemi culturali e dei valori di riferimento nei quali è inserito e in relazione ai propri obiettivi, aspettative, standard e interessi."

Tre elementi fondamentali emergono da questa definizione: 1. È **soggettiva**: ognuno percepisce la propria qualità di vita in modo personale 2. È **multidimensionale**: non si riduce a un solo aspetto della vita 3. È **misurabile**: sia con metodi quantitativi che qualitativi, con indicatori oggettivi e soggettivi

A cosa ci serve in pratica?

La professoressa (citando [Cottini, 2016](#)) chiarisce il doppio ruolo della QdV: - **Macro-finalità**: è l'orizzonte verso cui tendono tutti gli interventi educativi - **Strumento di valutazione**: ci permette di misurare se quello che facciamo sta davvero funzionando

Pensala come il GPS della pratica professionale: non solo indica la destinazione, ma verifica in continuo se ci stai andando davvero.

L'analogia dell'orchestra (la prof la ama)

La prof usa una metafora efficace: la qualità di vita è come un'orchestra sinfonica personale.

- La persona dovrebbe essere **il compositore** (scrive la partitura = definisce obiettivi e valori)
- **Il direttore d'orchestra** (interpreta e dà ritmo = gestisce la propria vita)
- **Il primo strumento** (partecipa attivamente = è protagonista)

La qualità complessiva del concerto dipende da: - Come il musicista interpreta la musica → **percezione soggettiva** - Il giudizio del pubblico → **valutazione oggettiva** - Quanti strumenti sono disponibili → i **sostegni** - Quanto ha potuto studiare → le **opportunità di sviluppo** - Il contesto della sala → i **fattori contestuali**

Se mancano strumenti (sostegni), anche la partitura migliore non basta.

Il Meta-Modello di Schalock e Verdugo

Cos'è un "meta-modello"?

Si chiama meta-modello perché è una sintesi di numerosi studi e modelli provenienti da discipline diverse, costruita in oltre vent'anni di ricerca. È riconosciuto a livello internazionale e usato non solo per la disabilità, ma anche per

anziani, persone con malattie croniche, e per valutare la qualità di vita dei lavoratori.

I 3 Fattori e gli 8 Domini

Il modello organizza la qualità di vita in una struttura a tre livelli: **fattori** → **domini** → **indicatori**.

Fattore	Dominio
Indipendenza	Sviluppo personale
	Autodeterminazione
Partecipazione sociale	Relazioni interpersonali
	Inclusione sociale
	Diritti
Benessere	Benessere emozionale
	Benessere fisico
	Benessere materiale

Questi 8 domini sono applicabili a **tutte le persone**, con o senza disabilità. La forza del modello è proprio questa universalità: non inventa categorie speciali, ma parte da quello che conta per tutti gli esseri umani.

Cosa dice la ricerca

Le evidenze scientifiche mostrano che la QdV migliora quando: 1. Le persone partecipano alle decisioni che le riguardano (empowerment / autodeterminazione) 2. C'è accettazione e inclusione nella comunità 3. Vengono forniti sostegni di qualità

I Domini nel Dettaglio

Fattore Indipendenza

Sviluppo personale → tutto ciò che riguarda l'apprendimento, la formazione, l'acquisizione di abilità, la possibilità di continuare a crescere nell'arco della vita. Esempi di indicatori: livello di educazione, abilità personali, comportamento adattivo.

Autodeterminazione → la capacità e la soddisfazione di fare scelte, esprimere preferenze, avere controllo sulla propria vita. **La prof sottolinea che questo dominio sarà approfondito nella lezione successiva: l'autodeterminazione si educa e si allena, e prima si comincia meglio è.** Esempi: scelte/decisioni, autonomia, obiettivi personali.

Fattore Partecipazione Sociale

Relazioni interpersonali → i contatti con familiari, amici, conoscenti. Non conta solo la quantità (quante persone nella rete), ma la qualità: **relazioni dove non sei sempre "l'oggetto di cura", ma puoi anche dare qualcosa agli altri.** Esempi: rete sociale, amicizie, attività sociali.

Inclusione sociale → sentirsi parte di una comunità, non solo parteciparvi formalmente. **Puoi essere fisicamente presente in un'attività comunitaria e sentirti comunque isolato.** Esempi: integrazione nella comunità, ruoli nella comunità.

Diritti → la garanzia e l'esercizio effettivo dei diritti umani e legali. **Non basta che i diritti esistano sulla carta: la persona deve conoscerli, sentirli e poterli vivere concretamente.** Include diritti umani (rispetto, dignità, uguaglianza) e diritti legali (assistenza legale, doveri di cittadino).

Fattore Benessere

Benessere fisico → salute, alimentazione sana, stile di vita attivo, accesso alle cure. **La prof fa un esempio pratico: puoi avere indicatori oggettivi (piramide**

alimentare, calorie) e soggettivi (sono vegetariana, mi piacciono i peperoni rossi). Entrambi vanno considerati e tenuti in equilibrio.

Benessere emozionale → sentirsi soddisfatti di sé e della propria vita, percepire emozioni positive, avere un buon rapporto con se stessi e il mondo. Include sicurezza, prevedibilità, autostima.

Benessere materiale → avere risorse economiche, effetti personali, un proprio spazio, condizioni abitative dignitose. Status finanziario, stato lavorativo, stato abitativo.

Gli Indicatori: dal Concetto alla Pratica

Cos'è un indicatore

Gli **indicatori** sono **percezioni, comportamenti o condizioni specifici** che permettono di misurare la qualità di vita. Senza indicatori, la QdV rimane un'intuizione vaga ("mi sembra che l'utente stia bene"). Con gli indicatori, diventa qualcosa che puoi osservare, misurare e su cui puoi progettare.

La prof usa la metafora di spacchettare: come non puoi "lavorare sulla sessualità" in generale, ma devi scomporla in relazioni, corpo, emozioni — così non puoi "migliorare la qualità di vita" in generale, ma devi identificare su quale dominio e quale indicatore specifico intervenire.

Oggettivi vs. Soggettivi

Tipo	Caratteristica	Esempio
Oggettivo	Basato su standard condivisi	Rispetto della piramide alimentare; numero di persone nella rete sociale
Soggettivo	Basato su preferenze e vissuti personali	"Mi piacciono i peperoni rossi"; "preferisco i gruppi piccoli"

Entrambi sono necessari. Se consideri solo gli oggettivi, costruisci una qualità di vita "normativa" che non corrisponde alla persona reale. Se consideri solo i soggettivi, potresti ignorare elementi importanti per la salute.

I Tre Sistemi (dimensione ecologica)

Cottini ricorda che il modello va visto in modo tridimensionale — i domini si muovono a tre livelli.

Sistema	Cosa include
Microsistema	La persona stessa, la sua crescita, le sue opportunità di sviluppo
Mesosistema	I servizi, le strutture, i progetti, gli operatori
Macrosistema	Le politiche sociali, le leggi, la cultura

Esempio pratico (la giostra a Mirabilandia): una persona vuole andare su una giostra. Il desiderio è stato ascoltato (microsistema). La Convenzione ONU garantisce il diritto all'autonomia e al tempo libero (macrosistema). Ma la giostra non è accessibile per chi ha difficoltà di deambulazione (mesosistema). Risultato: il desiderio non si realizza e la qualità di vita percepita ne risente su entrambe le dimensioni.

La valutazione va fatta **nel tempo**: la QdV cambia. Quello che era importante a vent'anni è diverso da quello che conta a quaranta. I progetti vanno rivalutati e **modificati continuamente**. Lepri (citato indirettamente dalla prof): i progetti di vita si scrivono "a matita".

Il Progetto di Vita

Cos'è e perché è diverso dal PEI/PSI

Il **progetto di vita** è lo strumento operativo principale per tradurre il paradigma della QdV nella pratica. È diverso dal PEI (Progetto Educativo Individualizzato) o dal PSI (Progetto di Sviluppo Individualizzato) perché:

- Non è limitato a un contesto specifico (scuola, struttura diurna, foyer)
- Abbraccia **l'intera traiettoria di vita** della persona
- Parte dai desideri, sogni e aspirazioni della persona
- È co-costruito con la persona, la famiglia e la rete di riferimento

La prof fa un esempio concreto: spesso i progetti del foyer (abitativo) e del centro diurno (lavorativo) non si parlano tra loro. Peggio ancora, possono avere obiettivi contraddittori — uno che lavora sulla socialità, l'altro che lavora sulla concentrazione individuale. Questo crea confusione, soprattutto per persone con disabilità intellettiva. Il progetto di vita è la cornice che dà coerenza a tutto.

"I progetti individuali nascono e si riconducono al progetto di vita... non dovremmo trovare obiettivi contraddittori." (Turati e Pozzi, 2024)

La legge italiana

La prof menziona che in Italia è stata varata una legge apposita sul "progetto di vita individuale" che richiede a ogni ASL di designare un **case manager**: la figura responsabile di co-costruire il progetto di vita con la persona e la sua famiglia, in modo trasversale a tutti i contesti di vita.

In Svizzera/Ticino questa figura non è ancora formalizzata. Nella pratica, è spesso il genitore a svolgere questa funzione — a volte per tutta la vita del figlio.

Come si co-costruisce (Turati e Pozzi, 2024)

Co-costruire un progetto di vita significa: - Prendere in considerazione tutte le variabili individuali e ambientali - Individuare e risolvere ostacoli, barriere e

discriminazioni - Programmare obiettivi e sostegni **partendo dai desideri e aspirazioni della persona** - Monitorare e valutare gli esiti in termini di QdV

Il punto di partenza è sempre il **desiderio**. Come scrivono Turati e Pozzi:

"Il progetto di vita realizza i desideri delle persone con disabilità. Ogni altro scopo, che parta da altri presupposti, lo svuota di senso."

La Valutazione Iniziale (Assessment)

Cos'è e a cosa serve

La valutazione iniziale (o **assessment**) è il primo passo di ogni progettazione. Il suo scopo è conoscere i desideri della persona e confrontarli con la situazione attuale, per capire quale cambiamento vogliamo raggiungere.

Si chiama anche **valutazione multidimensionale** perché adotta uno sguardo ecologico: tiene in considerazione sia le caratteristiche individuali sia quelle del contesto.

Il "modo di essere" di Carl Rogers

Turati e Pozzi richiamano **Rogers (1902-1987)**: per fare una buona valutazione, l'operatore deve avere una predisposizione relazionale basata su tre elementi:

1. **Autenticità**: essere sincero nell'intenzione di capire, senza maschere o atteggiamenti preimpostati
2. **Accettazione incondizionata**: posizione di accoglienza e non giudizio
3. **Empatia**: comprendere senza immedesimarsi totalmente, mantenendo lucidità e libertà di pensiero

Questa predisposizione viene **prima** delle competenze tecniche.

Il rischio del "services-led assessment"

Un rischio reale: l'operatore può finire per valutare non in base ai bisogni reali, ma in base ai servizi disponibili. Se so che posso offrire solo servizio A o B, tenderò a "vedere" solo i problemi che A o B risolvono.

Da evitare	Obiettivo
Services-led assessment (valutazione guidata dai servizi)	Needs-led assessment (valutazione guidata dal bisogno)

Gli strumenti di valutazione

La valutazione si può fare attraverso: - **Osservazioni partecipanti**: stare con le persone, cogliere situazioni - **Colloqui e interviste strutturate** basate sui domini della QdV - **Osservazioni documentali**: leggere materiale esistente sulla persona - **Interviste a familiari e operatori di riferimento** (necessarie quando la comunicazione diretta è limitata)

Attenzione: con persone che hanno difficoltà di comunicazione, lo strumento dell'intervista va adattato — lingua facile, CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa), immagini e simboli.

L'esercizio pratico in classe

La prof ha fatto sperimentare in classe un'intervista strutturata sul dominio dell'autodeterminazione. Obiettivo: allenare la capacità di tradurre un dominio in domande concrete, e bilanciare indicatori oggettivi e soggettivi. L'utente che veniva intervistato doveva dare feedback: "questa domanda la capisco?" — esercizio fondamentale per chi lavorerà con persone che hanno difficoltà di comprensione.

I PEI/PSI come Tasselli del Progetto di Vita

I Progetti Educativi Individualizzati e i Progetti di Sviluppo Individualizzati non sono alternativi al progetto di vita: sono **tasselli** di esso. Devono essere coerenti con gli obiettivi e la direzione del progetto di vita.

Caratteristiche fondamentali del PSI (secondo il modello ICF): - Aree di valutazione: funzioni corporee, strutture corporee, attività personali, partecipazione sociale, fattori contestuali ambientali, fattori contestuali personali - Stabilito in modo condiviso in équipe, con l'utente e la rete - Tiene in considerazione desideri, motivazioni, piaceri e passioni dell'utente - Tiene in considerazione anche le risorse dell'ambiente - Integrato con il piano settimanale delle attività

La Ricerca in Ticino (la Regione, 2023)

Elisa Geronimi (SUPSI) ha condotto una ricerca sulla qualità di vita delle persone con disabilità intellettiva nelle strutture socio-educative ticinesi.

Risultati principali: - Buon livello generale di QdV - **Migliori risultati:** benessere emozionale e benessere fisico - **Domini più critici:** inclusione sociale e diritti

Cosa migliora la QdV: - Prestazioni socio-professionali (laboratorio protetto) > prestazioni socio-occupazionali - Contesto comunitario (vivere con la famiglia) > contesto istituzionale - Maggiore autonomia (comportamento adattivo) → migliore QdV - **Le variabili ambientali contano più di quelle personali — importante per noi operatori, perché significa che possiamo intervenire!**

Domande di orientamento allo studio

Cos'è il paradigma della qualità di vita (QdV) e a cosa serve nella pratica educativa? La qualità di vita è la percezione soggettiva dell'individuo della propria posizione nella vita, nel contesto dei sistemi culturali e dei valori in cui è inserito, in relazione ai propri obiettivi, aspettative, standard e interessi (OMS, 1995). Ha tre

caratteristiche fondamentali: è soggettiva (ognuno la percepisce in modo personale), è multidimensionale (non si riduce a un solo aspetto) ed è misurabile (con indicatori oggettivi e soggettivi). Nella pratica serve con doppio ruolo: come macro-finalità (l'orizzonte verso cui tendono tutti gli interventi educativi) e come strumento di valutazione (per verificare se quello che si fa sta davvero funzionando).

Quali sono i 3 fattori e gli 8 domini del meta-modello di Schalock e

Verdugo? Il meta-modello organizza la qualità di vita in tre fattori con 8 domini:

(1) Indipendenza — Sviluppo personale (apprendimento, formazione, acquisizione abilità) e Autodeterminazione (fare scelte, esprimere preferenze, avere controllo sulla propria vita); (2) Partecipazione sociale — Relazioni interpersonali (rete sociale di qualità), Inclusione sociale (sentirsi parte della comunità) e Diritti (esercizio effettivo dei diritti umani e legali); (3) Benessere — Benessere emozionale (soddisfazione, emozioni positive, autostima), Benessere fisico (salute, alimentazione, cure) e Benessere materiale (risorse economiche, condizioni abitative, lavoro). Questi 8 domini si applicano a tutte le persone, con o senza disabilità.

Cosa sono i tre sistemi della dimensione ecologica e perché è

importante valutare tutti e tre? Il modello va visto in modo tridimensionale: il microsistema riguarda la persona stessa, la sua crescita e le sue opportunità di sviluppo; il mesosistema comprende i servizi, le strutture, i progetti e gli operatori; il macrosistema include le politiche sociali, le leggi e la cultura. È importante valutare tutti e tre perché un desiderio legittimo (microsistema) garantito dalla legge (macrosistema) può non realizzarsi se i servizi concreti non sono accessibili (mesosistema). L'intervento sull'uno o sull'altro sistema ha effetti diversi sulla qualità di vita percepita.

Cos'è il progetto di vita e in cosa si distingue dal PEI o dal PSI? Il progetto di vita è lo strumento operativo principale per tradurre il paradigma della QdV nella pratica. A differenza del PEI (Progetto Educativo Individualizzato) o del PSI (Progetto di Sviluppo Individualizzato), il progetto di vita non è limitato a un contesto specifico (scuola, struttura diurna, foyer), abbraccia l'intera traiettoria di vita della persona, parte dai desideri, sogni e aspirazioni, ed è co-costruito con la persona, la famiglia e la rete di riferimento. PEI e PSI sono tasselli del progetto di vita — devono essere coerenti con i suoi obiettivi e non contraddirsi tra loro. Come

scrivono Turati e Pozzi: "Il progetto di vita realizza i desideri delle persone con disabilità. Ogni altro scopo, che parta da altri presupposti, lo svuota di senso."

Cos'è il rischio del "services-led assessment" e come si evita? Il services-led assessment è una valutazione guidata dai servizi disponibili: l'operatore finisce per vedere solo i problemi che i servizi che conosce o che può offrire sono in grado di risolvere. È il contrario dell'obiettivo corretto: il needs-led assessment, ovvero una valutazione guidata dai bisogni reali della persona. Per evitarlo, l'operatore deve partire sempre dai desideri e bisogni della persona (non dai servizi disponibili), adottare la predisposizione relazionale di Rogers (autenticità, accettazione incondizionata, empatia), e usare strumenti diversi — osservazioni partecipanti, colloqui strutturati, interviste adattate (lingua facile, CAA) — per ottenere un quadro il più possibile fedele alla realtà della persona.

Cosa ci dice la ricerca di Geronimi (SUPSI, 2023) sulla qualità di vita in Ticino? La ricerca condotta da Elisa Geronimi sulle strutture socio-educative ticinesi mostra che le persone con disabilità intellettiva hanno complessivamente un buon livello di QdV, con i migliori risultati nei domini del benessere emozionale e del benessere fisico. I domini più critici sono l'inclusione sociale e i diritti. Cosa migliora la QdV: le prestazioni socio-professionali (laboratorio protetto) rispetto alle socio-occupazionali, il contesto comunitario (vivere con la famiglia) rispetto a quello istituzionale, una maggiore autonomia e comportamento adattivo. Il dato più rilevante per gli operatori: le variabili ambientali contano più di quelle personali nel determinare la QdV — il che significa che l'intervento professionale sul contesto ha un impatto reale e misurabile.

Concetti Chiave

Termine	Significato
Paradigma	Insieme di teorie e metodologie che fanno da sfondo concettuale alla pratica
QdV	Qualità di Vita — percezione soggettiva e multidimensionale del proprio benessere

Termine	Significato
Meta-modello	Modello che sintetizza molti altri modelli e ricerche (Schalock e Verdugo)
Dominio	Area tematica della QdV (es. autodeterminazione, benessere fisico)
Indicatore	Elemento specifico e osservabile che misura un aspetto della QdV
Assessment	Valutazione iniziale per conoscere la situazione e i desideri della persona
Progetto di vita	Progettazione globale e longitudinale che abbraccia tutta la vita della persona
PEI/PSI	Progetti individualizzati su specifici contesti — tasselli del progetto di vita
Case manager	Figura che coordina il progetto di vita trasversalmente a tutti i contesti
Microsistema	Livello della persona e del suo sviluppo
Mesosistema	Livello dei servizi, delle strutture, degli operatori
Macrosistema	Livello delle politiche sociali e delle leggi
Services-led assessment	Valutazione guidata dai servizi disponibili (da evitare)
Needs-led assessment	Valutazione guidata dai bisogni reali della persona (obiettivo)
Empowerment	Processo che trasferisce alle persone il potere di esigere i propri diritti

Collegamenti

- **Lezioni precedenti:** ICF e approccio bio-psico-sociale sono la base teorica della QdV; sistema dei sostegni; Convenzione ONU
- **Prossima lezione:** approfondimento dell'**autodeterminazione** — uno dei domini più dibattuti

Autori principali di questa lezione

Autore	Contributo
Schalock e Verdugo (2006)	Meta-modello della QdV — 3 fattori, 8 domini
Cottini (2016)	QdV come macro-finalità e strumento di valutazione; dimensione ecologica
Turati e Pozzi (2024)	Progetto di vita e disabilità — valutazione multidimensionale
Geronimi / SUPSI (2023)	Ricerca sulla QdV in Ticino
Croce / Anffas (2015)	Dal concetto intuitivo agli strumenti operativi
Edgerton (1990)	Prima critica alla mancanza di dati sulla QdV nelle persone con disabilità
Rogers (1902-1987)	Autenticità, accettazione incondizionata, empatia nella valutazione